

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE SENSIBILIDAD AL RECHAZO (RSQ)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación de la Hipervigilancia y Reactividad Afectiva ante el Rechazo

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Sensibilidad al Rechazo (RSQ).
Nombre Original	Rejection Sensitivity Questionnaire (RSQ; Downey & Feldman, 1996).
Autores Originales	Dra. Geraldine Downey y Dr. Scott I. Feldman (Universidad de Columbia, EE. UU.).
Adaptación Hispana	Romero-Canyas et al. (2010); adaptaciones validadas en España y Latinoamérica.
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Sensibilidad al rechazo, vulnerabilidad interpersonal y reactividad afectiva.
Tipo de Instrumento	Autoinforme situacional de 18 escenarios interpersonales con doble escala Likert de 6 puntos (1 a 6).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (desde 15 años). Ámbito clínico ambulatorio y de investigación vincular.
Tiempo de Administración	8 a 12 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Uso clínico y académico abierto bajo citación formal de la fuente original.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NEUROBIOLOGÍA DE LA SENSIBILIDAD AL RECHAZO

El constructo de **Sensibilidad al Rechazo** (SR; Downey & Feldman, 1996) describe un sistema cognitivo-afectivo disposicional caracterizado por la propensión a **esperar ansiosamente, percibir con facilidad e hipervigilancia, y reaccionar con intensidad desproporcionada** ante señales reales, ambiguas o imaginadas de desaprobación, exclusión o abandono interpersonal.

El modelo cognitivo-vincular postula que la SR surge comúnmente a partir de experiencias tempranas de rechazo parental, desapego afectivo, maltrato o victimización por pares (bullying). Estas vivencias consolidan esquemas de apego inseguro (ansioso-preocupado) en los que cualquier señal sutil (un tono frío, una demora en responder un mensaje o un gesto neutro) activa automáticamente una profecía autocumplida: el individuo experimenta pánico al rechazo, despliega conductas defensivas hostiles, sumisas o de retirada fóbica, y acaba provocando el distanciamiento efectivo del interlocutor.

A nivel neurobiológico, la SR se correlaciona con hiperactivación del circuito neural del dolor social (“matriz del dolor afectivo”): corteza cingulada anterior dorsal (dACC), ínsula anterior y amígdala extendida, asociada a una hipofunción de la corteza prefrontal ventrolateral encargada de la modulación cognitiva del dolor de exclusión. Presenta asimismo un elevado solapamiento con la Disforia Sensible al Rechazo (RSD) descrita en el TDAH del adulto y con el núcleo psicopatológico del Trastorno Límite de la Personalidad (TLP).

3. ESTRUCTURA SITUACIONAL Y DOBLE PONDERACIÓN POR REACTIVO

Contexto Interpersonal	Escenarios	Nº Ítems	Naturaleza de la Interacción Evaluada
1. Demandas a Pareja o Amigos	1, 4, 6, 8, 12, 16	6 escenas	Pedir apoyo emocional íntimo, favores personales y confirmación de afecto.
2. Solicitudes a Figuras de Autoridad	3, 7, 9, 13, 17	5 escenas	Pedir prórrogas a profesores/supervisores, aclaraciones o cartas de apoyo.
3. Interacciones con Pares y Extraños	2, 5, 10, 11, 14, 15, 18	7 escenas	Invitar a salir, pedir prestados apuntes/dinero y aproximarse a grupos ajenos.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Elevada homogeneidad métrica: alfa de Cronbach de 0.83 a 0.89 en muestras de validación y de 0.85 a 0.91 en adaptaciones hispanas. Fiabilidad test-retest $r = 0.78$ a 3 semanas y $r = 0.72$ a 4 meses, corroborando su naturaleza de rasgo disposicional estable.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio corrobora una dimensión general latente de Sensibilidad al Rechazo generada a partir del producto multiplicativo entre expectativa de rechazo e intensidad del afecto ansioso.
Validez Concurrente y Criterio	Correlación positiva significativa con Apego Ansioso (ECR-R, $r = 0.58$), Neuroticismo (NEO-PI-R, $r = 0.49$), Fobia Social (LSAS, $r = 0.52$), Depresión (PHQ-9, $r = 0.46$) y sintomatología límite (SCID-5-PD TLP, $r = 0.54$). Correlación inversa con Autoestima (RSES, $r = -0.51$).
Poder Predictivo Conductual	Predice significativamente rupturas de pareja conflictivas, celopatía no delirante, reactividad agresiva ante desaires sutiles y menor adherencia terapéutica debido a vivencias de rechazo transaccional con el terapeuta.
Invarianza de Género	Invarianza configuracional y métrica comprobada. Las mujeres tienden a registrar medias ligeramente mayores en escenarios afectivo-íntimos, mientras que los varones muestran mayor reactividad agresiva tras la percepción de desaire.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO MULTIPLICATIVO

Para cada uno de los 18 escenarios, el evaluado responde a dos reactivos con escalas Likert de 6 puntos:

- **Reactivo A (Ansiedad/Preocupación):** 1 = «Nada preocupado/ansioso» a 6 = «Muy preocupado/ansioso».
- **Reactivo B (Expectativa de Aceptación):** 1 = «Muy improbable» a 6 = «Muy probable».
- **Paso 1 (Inversión de la Expectativa):** Para obtener la **expectativa de rechazo**, se calcula: $\text{Expectativa de Rechazo}_i = 7 - \text{Expectativa de Aceptación}_i$.
- **Paso 2 (Puntaje Ponderado por Escenario):** Se multiplica la ansiedad por la expectativa de rechazo: $\text{SR}_i = \text{Ansiedad}_i \times (7 - \text{Expectativa de Aceptación}_i)$. (Rango por escena: 1 a 36).
- **Paso 3 (Puntuación Total RSQ):** Media aritmética simple de los 18 escenarios:

$$\text{Puntuación Total RSQ} = \frac{1}{18} \sum_{i=1}^{18} [\text{Ansiedad}_i \times (7 - \text{Expectativa de Aceptación}_i)]$$

- **Rango Total: 1.00 a 36.00 puntos.** A mayor puntuación, mayor severidad de la sensibilidad al rechazo.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntuación Total	Nivel de Sensibilidad	Significación y Conducta Clínica
Baja / Segura	< 7.00 puntos	Seguridad interpersonal	Baja vulnerabilidad; afronta negativas con ecuanimidad y objetividad.
Moderada / Media	7.00 a 10.99 pts	Sensibilidad normativa	Inquietud comprensible ante situaciones de alta trascendencia social; modulación afectiva adecuada.
Elevada	11.00 a 15.99 pts	Vulnerabilidad clínica	Hipervigilancia a señales de abandono; conductas evitativas o apaciguadoras frecuentes. Psicoterapia.
Muy Severa	>= 16.00 puntos	Desregulación extrema (>= 16)	Riesgo crítico de crisis de angustia, ira explosiva, descompensación afectiva y conductas autolíticas ante desaires.

MARCADOR CLÍNICO EN PERSONALIDAD LÍMITE Y TDAH (CORTE >= 16.00):

Un RSQ >= 16.00 es un indicador de alarma en el diagnóstico de Trastorno Límite de la Personalidad y Disforia Sensible al Rechazo (RSD). En estos pacientes, cualquier rechazo percibido desata una tormenta emocional aguda ("catastrofización vincular") con impulsividad autolesiva o heteroagresiva inmediata.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN HIPERVIGILANCIA AL RECHAZO

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN DESREGULACIÓN POR RECHAZO:

- **Paso 1 (Psicoeducación y Mapeo de Disparadores):** Identificar situaciones detonantes del RSQ (rechazo en pareja, amigos o jerarquías). Explicar el concepto de "hiperalgesia social" y la profecía autocumplida del rechazo.
- **Paso 2 (Terapia Dialéctica Conductual / Terapia de Esquemas):** Entrenamiento en habilidades de Tolerancia al Malestar (TIPP, STOP) y regulación emocional (DBT). Detección del modo "niño vulnerable" y "niño enfurecido/defensivo" ante la exclusión.
- **Paso 3 (Descatastrofización y Verificación de Hechos):** Técnicas de "Check the Facts" frente a interpretaciones automáticas paranoides ("tardó en responder porque me detesta"). Ensayos de comunicación asertiva dialéctica (DEAR MAN).
- **Paso 4 (Monitorización Clínica):** Un descenso sostenido de **≥ 4.00 puntos** en el RSQ total confirma un afianzamiento de la seguridad vincular.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN CRISIS VINCULAR Y APEGO ANSIOSO

Identificación: Mujer de 25 años, diseñadora gráfica, consulta tras severas crisis de angustia e ira desencadenadas cuando su pareja no atiende sus llamadas o interactúa con terceras personas en redes sociales. Refiere historial de bullying en la adolescencia y abandono afectivo paterno.

Evaluación Inicial RSQ (Línea Base): Puntuación Total = **18.44/36.00 puntos** (Rango de Desregulación Extrema / Alerta Crítica). Los escenarios de demanda afectiva a la pareja (ítems 1, 4, 8, 16) obtuvieron la puntuación máxima de 36.00 (Ansiedad = 6, Expectativa de aceptación = 1). ECR-R concurrente reveló apego ansioso elevado (percentil 95).

Plan Terapéutico: 16 sesiones combinando módulos de Terapia Dialéctica Conductual (DBT) y Terapia de Esquemas para el esquema de Abandono/Inestabilidad. Se entrenó la pausa de respuesta ante demoras en mensajería y se eliminaron las conductas de reaseguramiento coercitivo.

Reevaluación a los 4 Meses: Puntuación Total RSQ descendió a **9.80/36.00 puntos** (-8.64 pts, normalización en rango de Sensibilidad Moderada). La paciente logró mantener conversaciones de desacuerdo con su pareja sin activar reproches catastróficos ni ataques de pánico vincular.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

RIESGO AUTOLÍTICO ANTE RUPTURAS VINCULARES:

En pacientes con RSQ ≥ 16.00 , las rupturas sentimentales o los rechazos interpersonales agudos constituyen el principal precipitante de intentos suicidas impulsivos. Diseñar siempre un plan de contingencia de seguridad explícito.

SENSIBILIDAD AL RECHAZO VS. PARANOIA:

Diferenciar la hipervigilancia al rechazo (miedo neurótico al abandono con insight preservado) de la ideación delirante persecutoria o de autorreferencia en psicosis incipiente o trastorno de personalidad paranoide (contrastar con PDI-21).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Downey, G., & Feldman, S. I. (1996). Implications of rejection sensitivity for intimate relationships. *Journal of Personality and Social Psychology*, 70(6), 1327-1343.
2. Romero-Canyas, R., Downey, G., Berenson, K., Ayduk, O., & Kang, N. J. (2010). Rejection sensitivity and the rejection-hostility cycle in interpersonal relationships. *Personal Relationships*, 17(3), 395-415.
3. Eisenberger, N. I., Lieberman, M. D., & Williams, K. D. (2003). Does rejection hurt? An fMRI study of social exclusion. *Science*, 302(5643), 290-292.
4. Morán, V. E., Fissore, R., & Brandariz, M. (2018). Propiedades psicométricas del Cuestionario de Sensibilidad al Rechazo en adultos jóvenes. *Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento*, 10(3), 45-56.